



[首頁](#) > [傳染病與防疫專題](#) > [傳染病介紹](#) >

[第四類法定傳染病](#) > [流感併發重症](#) > [Q & A](#) >

[季節性流感疫苗](#) > [流感疫苗重點訊息](#) > [流感與流感疫苗簡介](#)

流感與流感疫苗簡介



全部收合

Q: 什麼是流感？



流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，傳染力強，可能造成重症或死亡，又可稱作「季節性流感」。感染流感後引起的症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，有部分感染者會伴隨有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，產生併發症時可能導致死亡；最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎等。長者、幼童、孕婦與慢性病患者是重症與死亡的高風險族群。

最後更新日期 2026/8/14

Q: 為什麼需要接種流感疫苗？



流感疫苗是預防流感最有效的方法，數十年的使用歷史已證明其安全性，6個月大以上之民眾，每年均建議接種流感疫苗。研究顯示接種流感疫苗有下列好處：

1. 接種流感疫苗可預防感染流感，或減少感染時的病情嚴重程度。
2. 接種流感疫苗可以降低與流感相關的住院和死亡風險。

3. 對於慢性疾病（如糖尿病、心臟病、慢性阻塞性肺病等）病人來說，感染流感會使原本慢性疾病惡化，因此疫苗是一項重要的預防措施。
4. 孕婦接種流感疫苗除可在懷孕和產後降低感染機率外，亦可在新生兒出生後提供保護力。
5. 接種疫苗可降低同住家人感染的機率，特別是未滿6個月之嬰兒照顧者，因嬰兒尚無法接種流感疫苗，建議照護者均應接種。

最後更新日期 2026/8/14

Q：流感疫苗如何產生保護力？



流感疫苗內含有當年度可能流行的3種流感病毒株抗原，藉由抗原刺激人體免疫系統產生抗體而形成保護力。接種後大約需兩週可產生足夠抗體。

最後更新日期 2026/8/7

Q：流感疫苗內的病毒株是如何選用的呢？



世界衛生組織（WHO）設有全球性流感病毒監測網絡，收集全球流行之病毒株，分析後定期召開會議決定當年度最可能流行之病毒株，建議3株（A/H1N1，A/H3N2，B/Victoria）具代表性之病毒用以製作當季流感疫苗。

最後更新日期 2026/8/7

Q：哪些人不適合接種流感疫苗（接種禁忌症， contraindications）？



絕大部分流感疫苗是不活化疫苗，民眾可安心接種，僅有以下接種禁忌症者不建議接種：

1. 已知對疫苗的成分有嚴重過敏者，不予接種。
2. 過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

3. 另外未滿6個月大之嬰兒因缺乏安全性與保護力相關資料，不建議接種。除此以外包括食物過敏、輕微上呼吸道症狀者，均可安心接種流感疫苗。

另外，鼻噴式流感疫苗(LAIV)為活性減毒疫苗，仿單記載接種禁忌症包括以下：

1. 如果對此疫苗任何成分(包括蛋類蛋白質) 曾有嚴重過敏反應 (例如立即型嚴重過敏反應[anaphylaxis])，或曾在接種任何流感疫苗後出現嚴重過敏反應，請勿接種。
2. 雷氏症候群(Reye syndrome)與同時使用阿斯匹靈(aspirin)或水楊酸類藥物的17歲以下兒童及青少年，請勿接種。
3. 嚴重免疫缺陷者，例如因急性和慢性白血病、淋巴瘤、有症狀的HIV 感染、細胞免疫缺陷、正在使用高劑量皮質類固醇或免疫抑制療法等具有臨床免疫缺陷的兒童和青少年，請勿接種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：我對雞蛋過敏，可以接種流感疫苗嗎？



可以。因大部分使用之流感疫苗，其病毒來自於雞胚蛋培養，傳統上認為疫苗中可能含有雞蛋蛋白成分，曾經建議有雞蛋過敏史者，接種疫苗後需觀察一段時間，確定未產生過敏反應。但近期研究顯示，因流感疫苗製程進步，內含的雞蛋蛋白成分已極少，雞蛋過敏者接種雞胚蛋培養之流感疫苗並不會增加過敏反應發生率，因此國際上皆建議雞蛋過敏者可安心照一般流程接種流感疫苗。

最後更新日期 2026/8/14

Q：為何每年都要接種流感疫苗？



由於流感病毒極易產生變異，幾乎每年流行的病毒株都會稍有不同，疫苗對不同抗原型之病毒保護效果會明顯降低，即使病毒未發生變異，疫苗成分相同，接種4-6個月後保護效果即可能下降，保護力一般不超過1年，因此建議每年均須接種1次，是全球一致性的作法。

最後更新日期 2026/8/14

Q：接種流感疫苗後會立即產生保護力嗎？

接種流感疫苗後大約需要兩週時間，才能產生完整保護力。而每年12月底至隔年2、3月為我國流感高峰期，因此，最好在每年10月份公費流感疫苗開打後儘速接種疫苗。

最後更新日期 2026/8/14

Q：什麼是甲醛？流感疫苗的成分中含有甲醛嗎？

1. 甲醛可用以使病毒去活化，以及對細菌毒素進行去毒性作用，用以製造人用疫苗至少已有50年之久。在製造疫苗的過程中，甲醛會被稀釋，但仍可以在最終成品中檢驗出少量殘留，因接種疫苗而單次暴露於甲醛之平均劑量非常低，因此被認為安全無虞。
2. 政府今年採購的各廠牌流感疫苗，其中國光生物科技股份有限公司、賽諾菲股份有限公司(標準型及加強型)、荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司、台灣東洋藥品工業股份(加強型)、高端疫苗生物製劑股份有限公司提供之流感疫苗，都含有微量甲醛或其殘留物；台灣東洋藥品工業股份有限公司提供之標準型流感疫苗則不含甲醛。各廠牌疫苗成分與詳細資料可參閱衛生福利部食品藥物管理署網站。

最後更新日期 2026/8/7

Q：什麼是硫柳汞？流感疫苗的成分中含有硫柳汞嗎？

1. 硫柳汞是一種含有汞的化合物。自1930年代以來，它被廣泛用作某些疫苗的防腐劑，主要目的是為了防止多劑型疫苗因反覆使用而被細菌或真菌污染。美國FDA的審查報告和長期的科學研究都顯示，除了少數人可能在注射部位出現輕微的局部反應或過敏外，沒有證據表明疫苗中的硫柳汞會對人體造成傷害。

2. 因為疫苗製程的進步，絕大多數單劑型疫苗已不含硫柳汞。政府今年採購的各廠牌流感疫苗，均不含有硫柳汞。各廠牌疫苗成分與詳細資料可參閱衛生福利部食品藥物管理署網站。

最後更新日期 2026/8/14

Q：政府如何確保流感疫苗的品質？



民眾接種的各廠牌流感疫苗皆需符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，同時每批疫苗均經食品藥物管理署檢驗合格，在品質上有保障。

最後更新日期 2026/8/14

Q：公費流感疫苗接種劑量及劑次為何？



6個月以上接種劑量為0.5mL，需注意各廠牌疫苗適用年齡略有不同。有關季節性流感疫苗接種劑次，經提115年3月11日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議討論決議，考量未滿3歲兒童初次接種流感疫苗時，完整接種 2 劑可顯著提升保護效益，故依年齡與過去接種史說明如下表。

流感疫苗過去接種史 ^{註1} /年齡組 ^{註2}	未曾接種	僅曾接種1劑者	曾接種2劑者
6個月以上至未滿3歲	2劑 (間隔4週以上)	2劑 (間隔4週以上)	1劑
3歲以上至未滿9歲	2劑 ^{註3} (間隔4週以上)	1劑	1劑
9歲以上	1劑	1劑	1劑

註1：流感疫苗過去接種史採當流感季前累計接種劑數計算，不限於同一個流感季接種。

註2：參依國際間接種建議，依幼兒於當年度流感季接種第1劑時之所屬年齡組及過去接種史，判定當年度流感季應接種劑數。

註3：未滿9歲但已入學者，依據99年3月23日ACIP第1次會議決議，

國小學童於學校集中接種流感疫苗，考量接種率、實務執行面等因素，統一提供1劑公費疫苗，故國小一、二年級學童若有第2劑流感疫苗接種需求，可於學校接種第1劑至少隔4週後，至醫療院所自費接種第2劑。

以115年10月1日開打為例，

範例一：

112年4月出生之幼兒，曾於112年11月(滿7個月)接種一劑流感疫苗，115年10月(滿3歲6個月)僅需接種一劑流感疫苗。

範例二：

112年11月出生之幼兒，曾於114年12月(滿2歲1個月)流感季接種一劑流感疫苗，則115年流感季接種情境如下：

- A. 若於115年10月(滿2歲11個月)接種115年流感疫苗，因未滿3歲且過往累計僅接種一劑，故應於間隔4週後接種第2劑。
- B. 若於115年12月(3歲1個月)接種115年流感疫苗，則無需接種第二劑。

範例三：

109年2月出生之國小一年級學童，出生至今未曾接種過流感疫苗，115年11月於學校接種一劑公費流感疫苗後，可於4週後自行前往醫療院所自費接種第2劑。

最後更新日期 2026/9/2

Q：若為未滿9歲需接種2劑者，2劑疫苗廠牌要一樣嗎？

^

各廠牌的疫苗雖然製程略有不同，但所含病毒之抗原性相似，其效果一樣，亦無安全之慮，經提109年7月6日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議討論決議，需接種2劑之兒童，2劑可接種不同廠牌疫苗。

最後更新日期 2026/9/2

Q：為何每個廠牌流感疫苗的適用年齡不同？

^

各廠牌流感疫苗之適用年齡，係根據臨床試驗資料經食品藥物管理署審查後制定，表示該廠牌疫苗用於該年齡對象時，有足夠證據支持其效果與安全性。其他年齡層對象則尚無資料可供解釋或說明其安全性及有效性。

最後更新日期 2026/8/7

Q：需接種2劑者，如接種間隔不足是否需進行補接種？



未滿9歲兒童初次接種，或未滿3歲兒童於本流感季前僅接種過1劑者，應接種2劑，2劑間隔4週以上，倘提前5天（含）以上接種者（即超過4天寬限期，2劑間隔<24天），第2劑應視為無效接種，需自無效之第2劑接種日起算最短間隔進行補種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：國產與進口不同廠牌及製程之流感疫苗，哪一種保護效果比較好？



不管國產還是進口疫苗，其產生的保護效果是一樣的。流感疫苗之疫苗株選擇，均依照世界衛生組織針對雞胚胎蛋培養疫苗及細胞培養疫苗建議，具有全球一致性且抗原性相同，並於國內具一致性檢驗標準。

最後更新日期 2026/8/14

Q：接種流感疫苗會不會造成感染流感？



流感疫苗包括不活化疫苗及活性減毒疫苗，不活化疫苗接種後不會造成流感感染；活性減毒疫苗內含的病毒株經減毒處理，無法在人體內有效複製，亦不會造成感染。接種季節性流感疫苗後48小時內如有發燒反應，應告知醫師曾經接種過流感疫苗，作為診斷參考。接種48小時後仍然持續發燒時，應考慮是否另有其他感染或引起發燒的原因。

最後更新日期 2026/8/14

Q：2026-2027流感季-流感疫苗一覽表



請點選以下連結開啟

附件

 [2026-2027流感季-流感疫苗一覽表.pdf](#)

最後更新日期 2026/8/7

Q：什麼是鼻噴式流感疫苗(LAIV)？今年政府有採購鼻噴式流感疫苗嗎？



鼻噴式流感疫苗是經鼻腔投予的活性減毒流感疫苗，是單劑預填式噴鼻器，每支含 0.2 毫升懸浮液。今年政府未採購鼻噴式流感疫苗。

最後更新日期 2026/8/7

Q：鼻噴式流感疫苗(LAIV)可否和其他疫苗同時接種？



美國疾病管制中心建議，鼻噴式流感疫苗可與其他疫苗(活性減毒或不活化)同時接種，若無法同時接種另一種活性疫苗，建議與該活性疫苗間隔至少四週再接種。至於與不活化疫苗之間，則可間隔任何時間接種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：什麼是加強型疫苗？和其他流感疫苗有何不同？



含有標準抗原劑量(每一病毒株15μg)且不含佐劑的流感疫苗，統稱為標準型流感疫苗，適合所有接種對象使用。加強型流感疫苗（或稱免疫加強型流感疫苗）則是專為免疫力較弱的高齡族群設計的流感疫苗。可分為兩類：

- 1. 含佐劑流感疫苗：在疫苗中加入特殊佐劑（如MF59），用來喚醒並放大免疫系統的反應。
- 2. 高劑量流感疫苗：將疫苗中的抗原劑量提高（約為標準型的4倍），以提供更好的免疫刺激。

比較項目	加強型流感疫苗 ^註 (High-Dose/Adjuvanted)	標準型流感疫苗 (Standard Dose)
適用對象	65歲(含)以上族群	滿6個月以上族群
成分差異	4倍抗原或添加佐劑	標準抗原量
保護效果	強力防護 重症保護力較標準劑量提升24.2%	基礎防護 成人保護力48%、重症保護力82%
局部反應	較明顯(紅腫、疼痛)	輕微(紅腫、疼痛)

註：加強型流感疫苗供貨種類及數量視各縣市配送情形而定，請以現場實際情況為準。

最後更新日期 2026/9/1

Q：什麼是佐劑？今年政府採購流感疫苗含有佐劑嗎？ ^

佐劑是疫苗藥品可能的組成之一，主要功能為協助誘發、延長或增強對目標抗原產生免疫反應。國內外皆已有含佐劑之流感疫苗上市。此外，今年政府另有採購加強型流感疫苗(包括含佐劑及高劑量)，優先提供安養、長期照顧(服務)等機構之65歲以上受照顧者及所屬工作人員接種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：含佐劑流感疫苗可否和其他疫苗同時接種？ ^

含佐劑流感疫苗可和其他疫苗同時接種，或間隔任何時間接種。若與另一種注射疫苗同時接種時，應於不同肢體進行接種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：什麼是高劑量流感疫苗？今年政府有採購高劑量流感疫苗嗎？

^

高劑量流感疫苗之每株病毒抗原含量為標準型流感疫苗的4倍，主要功能為誘發更強的免疫反應。此外，今年政府另有採購加強型流感疫苗(包括含佐劑及高劑量)，優先提供安養、長期照顧(服務)等機構之65歲以上受照顧者及所屬工作人員接種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：高劑量流感疫苗可否和其他疫苗同時接種？

^

高劑量流感疫苗可和其他疫苗同時接種，或間隔任何時間接種。若與另一種注射疫苗同時接種時，應於不同肢體進行接種。

最後更新日期 2026/8/7